HELP_Organi_P25 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 25 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-054 — Moyenne — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › lacunes (218.13, 218.19) ; point 3 Épidémiologie ; evidence not_found n° 2 et 9

Contexte : Fréquence suisse des hormonothérapies d'affirmation, des consultations d'incongruence de genre et des suppressions pubertaires, et violence de couple chez les couples de même sexe : « donnée non trouvée ».

Question : Quels chiffres suisses (OFS statistique médicale des hôpitaux, Obsan, centres universitaires, Bureau fédéral de l'égalité) existent sur les traitements d'affirmation de genre, les suppressions pubertaires et la violence de couple chez les couples de même sexe ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-057 — Moyenne — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › lacunes (218.20) ; evidence not_found n° 11

Contexte : Les directives de Transfusion CRS Suisse sur le don de sang des HSH n'ont pas été lues.

Question : Quels critères d'exclusion ou de délai de Transfusion CRS Suisse s'appliquent en 2026 au don de sang des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des personnes trans, et depuis quelle date ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-058 — Moyenne — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 Cadre légal (LEg) ; evidence uncertainties n° 9

Contexte : La SSED affirme que la LEg protège les personnes trans ; l'art. 3 LEg parle de discrimination « à raison du sexe » sans mention de l'identité de genre.

Question : La jurisprudence suisse (Tribunal fédéral ou tribunaux cantonaux) ou le Bureau fédéral de l'égalité reconnaît-elle que la LEg protège contre la discrimination fondée sur l'identité de genre, et quel autre texte (CP art. 261bis) couvre l'orientation sexuelle ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-059 — Haute — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point XI.B › tableau des moyens pharmacologiques › ligne « Appoint : benzodiazépines » ; aussi LOT_217 evidence uncertainties n° 10

Contexte : LOT_219 : benzodiazépines 2 semaines, maximum 4, dans l'épisode sévère avec suicidalité [S25] ; dose et spécialité « donnée non trouvée ». LOT_217 : conflit Temesta® (≤ 2–3 mois) / SGAD 2024 (2, max 4 semaines) / OMS 2013 (aucune benzodiazépine le premier mois post-traumatique).

Question : Quelle benzodiazépine, quelle dose (IP suisse de Temesta® ou autre) et quelle durée maximale recommande la recommandation suisse la plus récente sur la dépression (SSAD 2024 ou suivante) en appoint de l'épisode dépressif sévère, et quelle position adopte la recommandation suisse ou européenne sur les benzodiazépines après un traumatisme aigu ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez

toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-061 — Haute — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point III (piège violence domestique) et point XI (protection) ; evidence not_found n° 8, 10 et uncertainties n° 4, 5

Contexte : Le cours cite la feuille BFEG n° 6 (2012 ; SPC 2011 : 26,2 % d'ex-partenaires) ; la part des ex-partenaires 2025 (OFS 3.2.3) n'est pas extractible ; les instruments cantonaux d'évaluation de la dangerosité ne sont pas consultés ; statistique nationale de protection de l'enfance 2025 (2380 enfants) de source secondaire.

Question : Quelle part des infractions de violence domestique concerne d'anciens partenaires selon la statistique policière OFS la plus récente, quels instruments d'évaluation du risque de violence domestique (DyRiAS, ODARA ou autre) utilisent les cantons, et quels chiffres publie la statistique nationale de protection de l'enfance 2025 ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-062 — Haute — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point II Définitions (trouble de l'adaptation, épisode dépressif) et tableau des critères ; evidence not_found n° 2, 3, 9 et uncertainties n° 10 ; aussi LOT_222 not_found n° 4

Contexte : LOT_219 : le texte officiel CIM-11 (6B43 trouble de l'adaptation, épisode dépressif) n'est pas lu (navigateur inaccessible) ; définition via Zelviene 2018 ; statut de l'« aliénation parentale » non vérifié. LOT_222 : QD85 (burnout) et 6B43 non lus, seule la définition OMS 2019 du burnout.

Question : Quels sont les textes exacts des exigences diagnostiques CIM-11 (CDDR 2024) pour 6B43 trouble de l'adaptation, 6A70–6A71 épisode dépressif et QD85 syndrome d'épuisement professionnel, la CIM-11 contient-elle une entité ou un code « aliénation parentale » (QE52.0 ?), et quelle est la prévalence suisse du trouble de l'adaptation ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-064 — Haute — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point XI.C › tableau de surveillance (acamprosate, naltrexone, disulfirame) ; aussi LOT_222 evidence uncertainties n° 7

Contexte : LOT_219 : créatinine > 120 µmol/L : acamprosate contre-indiqué ; autres seuils d'arrêt (naltrexone, disulfirame) « donnée non trouvée ». LOT_222 : conflit HUG 2017 (Campral® selon le poids) / IP 2023 (2 cp 3×/j sans distinction) arbitré pour l'IP.

Question : Quelles posologies et quels seuils biologiques d'arrêt (transaminases, créatinine) prévoient les IP suisses de Campral®, de la naltrexone et de l'Antabus® (disulfirame), et quel calendrier de surveillance hépatique imposent-elles ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-060 — Moyenne — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point III Épidémiologie (tableau SILC, dépense imprévue de 2500 francs) ; evidence not_found n° 1, 6, 7 et uncertainties n° 1, 2, 3 ; aussi LOT_226 uncertainties n° 2

Contexte : Le cours cite SILC 2018 (48 % des ménages monoparentaux incapables d'une dépense imprévue de 2500 francs ; pauvreté 19,3 %) et 10,6 % en 2023 (CSIAS citant l'OFS) ; aide sociale 18,6–19,6 % ; nombre annuel d'enfants mineurs touchés par un divorce et santé des enfants de familles recomposées non trouvés ; date du communiqué SILC 2024 incertaine.

Question : Quels chiffres OFS les plus récents existent sur le nombre de divorces et d'enfants mineurs concernés, le taux de pauvreté et de privation matérielle des ménages monoparentaux (SILC 2024, date de publication exacte), le taux d'aide sociale des familles monoparentales et la part des familles recomposées ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-063 — Moyenne — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre bio-mathématique 9.2 (AUDIT) ; evidence not_found n° 12

Contexte : Le cours source l'AUDIT complet (Saunders 1993, résumé) ; l'AUDIT-C et ses seuils suisses de validation : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils de l'AUDIT-C (homme, femme) et de l'AUDIT complet sont validés en Suisse ou recommandés par l'OFSP, Addiction Suisse ou la SSAM, avec la sensibilité et la spécificité ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-065 — Moyenne — LOT 219 · SSP O6.6

Emplacement : LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point VI Cadre légal (autorité parentale, beau-parent) ; evidence not_found n° 13 et uncertainties n° 11

Contexte : Les numéros d'alinéas CC 298 al. 2bis/2ter et CC 301 al. 1bis ne sont pas visibles dans l'extraction Fedlex ; le statut du concubin non marié pour représenter l'enfant du partenaire (équivalent de CC 299) n'est pas trouvé.

Question : Quelle est la numérotation exacte en vigueur des alinéas de CC 298 et CC 301 (garde alternée, prise en charge, décisions courantes), et quelle base légale permet au concubin non marié de représenter l'enfant de son partenaire (CC 300 ?) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-066 — Haute — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point III Épidémiologie (220.1) ; evidence not_found n° 2

Contexte : Le dernier chiffre officiel lu date de 2016 (928 suicides assistés, 1016 suicides) ; la réponse Gemini (HELP LOT_248 V1 n° 3) donne 995 suicides hors suicide assisté en 2023, sans les suicides assistés.

Question : Combien de suicides assistés l'OFS a-t-il enregistrés en 2022, 2023 et 2024, et combien de suicides (hors assistance) en 2024, avec l'URL du tableau OFS ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-068 — Haute — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 7.4 (Takotsubo), fenêtres « Score diagnostique InterTAK », ECG, imagerie (allergie, stimulateur) ; tableau comparatif DX.8 ; evidence not_found n° 4, 11 et uncertainties n° 8

Contexte : Le cours cite le consensus InterTAK [S45] (pondération des items non lue) et la position HFA 2016 en résumé ; Triatec® et Beloc Zok® n'ont pas l'indication Takotsubo ; imagerie en cas d'allergie aux produits iodés ou de stimulateur non compatible : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle pondération des items du score diagnostique InterTAK, quelle conduite aiguë (obstruction du VG, choc, anticoagulation du thrombus) et quel traitement au long cours (IEC/ARA, bêtabloquant) recommandent le consensus InterTAK et la position la plus récente de l'ESC/HFA, et quelle est l'incidence suisse du syndrome de Takotsubo ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-071 — Haute — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableaux comparatifs DX.7 (deuil périnatal) et DX.4 (PGD) ; point 11.B (aucune spécialité pour le PGD) ; evidence not_found n° 8 et 10

Contexte : Le cours cite NICE NG116 pour le TSPT et une psychothérapie spécifique (PG-CBT) pour le PGD ; recommandation suisse sur le deuil, le deuil périnatal (SSGO) et le TSPT, position EPA sur le PGD, reconnaissance par l'AI : « donnée non trouvée ».

Question : Quelles recommandations suisses (SSGO sur le deuil périnatal, SSPP/SSAD sur le TSPT) ou européennes (EPA, ESTSS) fixent la prise en charge du deuil périnatal, du TSPT et du trouble de deuil prolongé, et l'AI reconnaît-elle le PGD comme atteinte invalidante ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-072 — Haute — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 Cadre légal (congé de deuil, rentes de survivants) ; evidence not_found n° 9 et uncertainties n° 13

Contexte : Le cours cite CO 329 al. 3 (« jours usuels ») et LAVS art. 23–24 (consolidation au 1.1.2026) ; une réforme des rentes de veuve et de veuf est discutée au Parlement.

Question : Quel est l'état au 22.10.2026 de la réforme des rentes de veuve et de veuf (LAVS art. 23–24 : texte adopté, date d'entrée en vigueur, régime transitoire), et existe-t-il une durée légale ou jurisprudentielle de congé de deuil (CO 329) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-073 — Haute — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « Loi sur la transplantation (LTx) art. 9 » ; evidence uncertainties n° 10

Contexte : Le cours retient la page OFSP (consentement présumé « premier semestre 2028 ») et la LTx en vigueur (consentement explicite) ; le détail des examens de constat de la mort : « donnée non trouvée ».

Question : À quelle date le consentement présumé au sens large entre-t-il en vigueur (ordonnance du Conseil fédéral, registre), et quels examens cliniques et paracliniques exigent les directives ASSM « Diagnostic de la mort en vue de la transplantation » dans leur version la plus récente ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-067 — Moyenne — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point III Épidémiologie (220.0) ; evidence not_found n° 1 et 3

Contexte : Le cours cite 71 900 décès en 2024 (OFS) et un PGD chez 9,8 % des endeuillés (méta-analyse) ; nombre annuel d'endeuillés, prévalence suisse du PGD selon la CIM-11 (seules données : Zurich, personnes âgées, critères anciens) et de la dépression du deuil : « donnée non trouvée ».

Question : Existe-t-il une prévalence suisse ou européenne représentative du trouble de deuil prolongé selon les critères CIM-11 (6B42) et de l'épisode dépressif après un deuil, publiée après 2020 ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-069 — Moyenne — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 7.5 (épuisement du proche aidant), fenêtre « Zarit Burden Interview », tableau comparatif DX.2 ; evidence not_found n° 6 ; aussi LOT_226 not_found n° 6

Contexte : Le cours cite une sensibilité du ZBI de 77,3–85,2 % [S68] et une intensité d'aide > 10 h/semaine comme facteur de vulnérabilité [S10] ; seuils validés en Suisse du ZBI (22, 12 et 4 items), critères formels de l'épuisement et seuil de l'échelle de solitude en 3 items : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils du Zarit Burden Interview (versions 22, 12 et 4 items) et de l'échelle de solitude en 3 items (Hughes) sont validés en français ou en allemand, et existe-t-il des critères formels suisses de l'épuisement du proche aidant (OFSP, Pro Senectute, société savante) ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-070 — Moyenne — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtres IPGDS et PG-13-R (point 9 et tableau DX.4)

Contexte : Le cours cite le PG-13-R (seuil 30, kappa 0,70–0,89) ; score seuil et valeur normale de l'IPGDS : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils diagnostiques et quelles performances (sensibilité, spécificité) ont l'IPGDS et le PG-13-R pour le trouble de deuil prolongé selon la CIM-11, et existe-t-il une version validée en français ou en allemand ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-074 — Moyenne — LOT 220 · SSP O6.7

Emplacement : LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableaux DX.9 (enfant endeuillé), point 9.c (enfant) et fenêtre 9.3 (LOT_219) ; evidence

not_found n° 5 ; aussi LOT_219 LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html fenêtre 9.3

Contexte : LOT_220 : instruments pédiatriques validés en Suisse pour le deuil et le TSPT « donnée non trouvée » ; aucun médicament du TSPT avant 18 ans. LOT_219 : aucune échelle pédiatrique validée spécifique du risque suicidaire.

Question : Quels instruments pédiatriques validés en français ou en allemand (deuil prolongé de l'enfant, TSPT : CATS, CRIES ; risque suicidaire : ASQ, C-SSRS pédiatrique) recommandent la SSPPEA/SGKJPP ou une source européenne ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P25 — 19 questions : F-054, F-057, F-058, F-059, F-061, F-062, F-064, F-060, F-063, F-065, F-066, F-068, F-071, F-072, F-073, F-067, F-069, F-070, F-074